



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : منار ابراهيم رجب عرفات
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : المعادي
رقم البطاقة : 28901210102461 رقم التليفون : 01280500208
العنوان : ممممممممممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 21-01-1989 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منار ابراهيم رجب عرفات National ID: 28901210102461	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة لتحديد الشخصية

منار
ابراهيم رجب عرفات
٢٧ ش فتحي عبدالمقصود
المعادي - القاهرة

٢٨٩٠١٢١٠١٠٢٤٦١

JE9391168

٢٠٢٢/٠١ ٢٨٩٠١٢١٠١٠٢٤٦١
بكالوريوس نظم معلومات ادارية

انثى مسلمة متزوجة
تامر ابراهيم عباس ابراهيم
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠١/٠١

٦٢٩٤٤٧٨٦ رقم القرار / تم الرفع

لتمه على الفقد MRI

Patient Name : منار ابراهيم رجب عرفات
Patient Info. : Female 37Y
Department : Out Clinic
Profile NO. : 5392-2021/ 28901210102461

Patient Id : 4138
VisitId : 7346
Collection Date : 16/12/2025 13:24:23
Reporting Date : 16/12/2025 13:44:57

Clinical Chemistry Report

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
<u>Kidney Function</u>			
Calcium Ionized (Ca++)	: 1.11	mmol/L	N. 1.1 - 1.4

Signature
Dr. Radwa Mohammed

Name: MR. :	منار ابراهيم رجب 6294	
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is prescribed an oral regimen of letrozole (Femara) taken once daily, calcium supplementation 1 tablet daily, a depot formulation of goserelin (Zoladex) 10.8 mg, and intravenous zoledronic acid (Zometa) 4 mg. The patient is a 37-year-old premenopausal female who presented with a right breast mass classified as cT3N1. Pathology showed estrogen receptor 6/8 positive, progesterone receptor 5/8 positive, HER2 3+ positive, and Ki-67 30 %. She received neoadjuvant chemotherapy with the TCHP regimen, followed by a surgical mastectomy in July 2022 (pathology pT0N1). Post-operative therapy included trastuzumab-emtansine (Kadcyla) and radiation (PORT). She has been maintained on letrozole, goserelin, and zoledronic acid, with zoledronic acid scheduled for administration in April at the pharmacy along with continued goserelin and letrozole. The plan today was to administer letrozole. The patient presented for scheduled zoledronic acid administration; however, laboratory evaluation revealed a low calcium level, and the zoledronic acid infusion was postponed pending correction of the calcium deficiency.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 21-09-2026
	ايه مدحت بدوي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

د. محمد بن عبد الله

MDT FORM

11/11/2022

C19C
C.C.I

Name	صالح بن عبد الله	MRN	
Age	33 yrs	ID	C19C-111-111-111
Menopausal status		Phone	011-000-0000
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:	IDC G1			
ER:	PR:	HER 2:	K67:	
6/8	5/8	3+		
Sonomammography:				
1ml 0 CT3-N1-NAC				RT SM + SLNBx → 13-7-2022 TNM
Mets Workup				
ACx11 THP x4 last (7/6/2022)				
Recommendations				

- * yp Tc, yp N,
 - * no residual invasive Tumor Tissue.
 - * scattered lymphovascular invasion
 - * Free nipple & Areola.
 - * SLNBx (2/3) + micrometastasis + lymphovascular invasion
- MDT OUTCOME & PLAN
- * Free Deep margin
 - * partial pathological response.

- for Kadcyla (TDM1) for 4 cycles
- PORT
- AC + Zoladex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
Dr. [Signature]	Dr. [Signature]	Dr. [Signature]	Dr. [Signature]

Patient Name : الأستاذ / منار ابراهيم رجب عرفات	Request No. : 13007924
Patient No. : 28901210102461	Request Date : 18/07/2022
Path No. : 1973/22	Verification Date : 25/07/2022
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 33 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer, Post NACT.

Nature of the specimen: SLNs biopsy and Right simple mastectomy specimen.

Gross Examination: Two specimens were received:

1- SLNs biopsy: Three fibrofatty tissue pieces measured 4x 0.5cm collectively enclosing 3 lymph nodes (largest 1x1x0.5cm, smallest 0.5x0.5cm).

2- Right Simple mastectomy specimen: measured 22x17x5cm with skin covering measure 22x17cm.

• Localization: Retroareolar.

• Tumor extent

o Number: cut section revealed an ill defined retroareolar rubbery grayish white tumour bed site.

o Size: measured 3x2.5x1.5cm.

o Skin involvement: unremarkable grossly.

• Distance from margins: 1.5cm from skin and 5cm from deep margin.

• Frozen section: Positive in 1/3 SLNs.

Microscopic examination:

• Histological type: No residual invasive tumour tissue.

• Scattered lymphovascular invasion.

o Skin involvement: Free nipple and areola.

• Lymph node involvement: Positive sentinel lymph node micrometastasis with lymphovascular invasion (2/3).

• Resection Margins: Free deep margin.

• Histologic response to therapy: partial pathological response.

Verified by :

DR.Menna Nabil

Patient Name : الأستاذة / منار ابراهيم رجب عرفات	Request No : 13007924
Patient No : 28901210102461	Request Date : 18/07/2022
Path No : 1973/22	Verification Date : 25/07/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 33 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Diagnosis:

Right breast cancer, SLNs biopsy and Right Simple mastectomy specimen:

- No residual invasive tumour tissue.
- Scattered lymphovascular invasion.
- Free nipple and areola.
- Positive sentinel lymph node micrometastasis with lymphovascular invasion (2/3).
- Free deep margin.
- Partial pathological response to the therapy.
- Stage: ypT0, ypN1.

El Mahdy.

Prof. Dr. Manal

Dr.Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 02/08/2022 13:37:14

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

PATIENT NAME: MANAR IBRAHIM RAGAB Arfat	PATIENT ID #: 2021176499
GENDER: Female	ORDER #: 1373025,1373026
AGE: 32 y	DATE OF SERVICE: 19-Dec-2021 02:42 PM

Report: - all studies

Multislice post contrast CT scan of the chest, abdomen and pelvis with special triphasic study of the liver revealed:

(I) Chest:

- Right breast multiple enhancing nodules are noted, the largest seen measuring about 21x17.7 mm in the UIQ. Associated multiple ipsilateral pathologically enlarged axillary lymph-nodes, the largest seen measuring about 23.1x12.1 mm.
- Bilateral basal thick atelectatic bands are noted.
- No parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.
- Bilateral thyroid lobes hypodense nodules are noted. For sonographic correlation.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is increased in size showing homogenous CT density and enhancement with segment VIII small hypodense non enhancing focal lesion seen measuring about 5.5 mm, likely cyst.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Bulky uterus with right adnexal marginally enhancing cyst, seen measuring about 27.6x27.6 mm. for sonographic correlation.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- ***The examined axial and appendicular skeleton shows D6 and L3 vertical trabeculations likely hemangiomata and tiny sclerotic***



Presidential Program for Women's health

Name: Manar Ibrahim Ragab

Date: 14/11/2021

Bilateral Full field Digital Mammography and ultrasound

Clinical summary. 33 old female patient for evaluation of right palpable lump

Technique

Mediolateral oblique and CC views

High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular pattern(ACR b)
- Multiple irregular ill- defined spiculated dense masses are seen at UOQ and UIQ extending from the nipple to the middle third with suspicious groups of microcalcifications.
- Normal skin, nipple and areola complex
- **Ultrasound**
 - Demonstrated an ill-defined hypoechoic irregular shaped masses with spiculated margins and internal calcifications seen as follow:
 - at 12:00 (index mass) measuring about 22 x 23 mm showing internal calcifications and vascularity depicted by Color Doppler study
 - Another similar small masses: seen located nearby, measuring about (7x 8 mm) and
 - at 9:00 measuring (1 x 0.9 cm)
 - Multiple pathological axillary lymph node with effaced hilum, largest one measures about 20mm in long axis with cortical thickening reaching 13 mm

left breast

- Scattered fibroglandular pattern(ACR b)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated
- No solid or cystic lesions
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Conclusion:

- **Right breast:** (BIRADS 5) UOQ and upper central multifocal malignant looking masses with suspicious microcalcifications and ipsilateral pathological axillary LN as described (US guided biopsy was done on today's setting for histopathological correlation).
- **left breast:** Normal study (BIRADS 1).

Best regards,

Dr. Eman Ali

Dr. Walea hussein

Dr. Hanna Abu Almagd

جمهورية مصر العربية
مركز بحوث النحس

منار
ابراهيم رجب عرفات
٢٧ ش فخرى عبدالمقصود
المعادى - القاهرة

١٩٨٩/٠٧/٠١

٢٨٩.٠١٢١.٠١.٢٤٦١

JE9391168

٢٠٢٢/٠١ ٢٨٩.٠١٢١.٠١.٢٤٦١

بكالوريوس نظم معلومات ادارية

انثى مسلمة متزوجة
تامر ابراهيم عباس ابراهيم
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠١/٠٤

١

Dr
منصة الابحاث والتحليل

عادل